

选择主刀医生

两位医生都问同样的问题

供向李萃萃医生、孙振兴医生分别追问。记录各自的回答；尚未明确的内容请标注“待确认”，不要自行补全。

开场可以这样说：

“我最关心的是保住现有的腿部和大小便功能，同时尽量降低再次栓系的风险。请您结合我的原始影像，解释适合我的方案，以及您本人做类似手术的经验。”

病历提示：成人脂肪瘤相关脊髓栓系；MRI脂肪瘤约121毫米，CT约129毫米；左L5神经根被包绕、左S1神经节受压；有皮肤窦道影像表现及既往大小便功能障碍。请医生核对实际解剖，不以摘要代替阅片。

1 谁亲自主刀？最关键的步骤由谁完成？

“是您本人完成松解、脂肪瘤与神经根的分离，以及硬膜关闭吗？如果由其他医生完成，请告诉我姓名和具体分工。术中遇到困难时，谁可以支援？”

2 您本人最近做过多少真正相似的病例？

“过去一年或两年，您作为主刀做过多少例成人、脂肪瘤相关、神经根被包绕的脊髓栓系手术？其中有多少例像我这样已经有大小便障碍？”

请区分：个人主刀量 / 团队总量，成人 / 儿童，复杂脂肪瘤 / 单纯终丝切断。总脊柱手术量不能替代类似病例量。

3 我的具体分型和松解目标是什么？

“请在片子上指出：哪些结构造成栓系？左L5神经根与脂肪瘤是什么关系？计划解除哪些牵拉、压迫或粘连？是否需要终丝切断，依据是什么？”

4 准备切多少脂肪瘤？什么情况下会停止？

“哪些部分准备切，哪些部分会保留？为什么这样最适合我？如果脂肪与有功能的神经分不开，或监测信号变化，您会怎样调整？”

不预设“切得多”或“切得少”更好。重点是如何权衡新增神经损伤与残余栓系 / 再次栓系风险。

5 如何监测并保护腿部和大小便功能？

“本次会使用哪些术中神经电生理监测？是否包括神经根定位 / 触发肌电图、运动和感觉通路，以及肛门括约肌或球海绵体反射？哪些适用、哪些不适用？由谁负责，出现警报时如何处理？”

时间有限时先问第1—5题。可以请求医生画图或写下简短方案；录音前先征得同意。

风险、恢复与最终确认

6 皮肤窦道、硬膜及骨性缺损怎么处理？

“影像上的窦道是否与椎管相通？是否同次处理，如何确认范围？如何关闭或重建硬膜，降低脑脊液漏及再次粘连风险？S2/S3椎板缺损是否影响方案？需要内固定或植入材料吗，为什么？”

7 您类似病例的实际结果怎样？

“您的成人复杂脂肪瘤病例中，新增永久性腿部无力、大小便功能恶化、脑脊液漏、感染及再次手术各有多少？分别是多少例中的多少例？随访多久？有无可参考的病例系列或论文？”

请分清短暂变化与永久损伤、短期恢复与长期再次栓系，以及个人结果与团队结果。没有统计数据可以直说，不把网上好评当作并发症率。

8 对我而言，目标和手术时机是什么？

“哪些功能最可能稳定、哪些可能改善、哪些恢复希望较小？如果暂缓手术，您担心什么，什么症状需要立即回医院？术前还需要哪些检查或尿动力学评估？”

9 术后由谁管理，出现问题找谁？

“预计住院和在北京复查多久？伤口、脑脊液漏、排尿不畅或新发无力由谁处理？请给具体联系方式。何时评估膀胱功能，是否需要泌尿科、导尿或康复支持？如考虑骶神经调控，依据、评估和试刺激流程是什么？”

10 请明确牙齿、返程及费用安排

“我的智齿目前不舒服，需要先做口腔检查或治疗吗？若没有感染，术后满足什么条件才能拔牙？何时可以坐长途飞机？请根据恢复情况决定，不只给固定天数。预交金、费用范围及主要自费材料有哪些？”

结束前，请两位医生各自确认这四项：

- ① 实际主刀姓名及类似病例经验；② 针对我的切除/保留方案与理由；
- ③ 主要风险和保护措施；④ 手术安排、复查及紧急联系渠道。

记录：医生/医院：_____ 面诊日期：_____

最关键的回答或尚未解决的问题：

此清单用于知情沟通，不指定术式、不替代医生判断，也不预设哪位医生更优。请带原始DICOM、MRI/CT报告及尿动力学报告。